

Psychotropes et risque de chute

🧑 Les chutes représentent la 1^{ère} cause de mortalité accidentelle chez les personnes âgées de plus de 65 ans, avec 10 000 décès annuels.

💊 Ce risque de chute est augmenté chez les usagers de traitements psychotropes, nécessitant une vigilance particulière, quel que soit l'âge. Presque tous les psychotropes sont concernés, plusieurs effets indésirables peuvent être impliqués dans la survenue de chutes.

😴 effets sédatifs

- ▶ anxiolytiques et hypnotiques : toutes les benzodiazépines et apparentées (Z-médicaments), hydroxyzine
- ▶ antipsychotiques : clozapine, quétiapine, olanzapine, cyamémazine, lévomépromazine, etc.
- ▶ antidépresseurs : mirtazapine, miansérine, amitriptyline, etc.

🩺 hypotension orthostatique (lors du passage de la position allongée/assise à debout) :

- ▶ surtout les antipsychotiques : clozapine, quétiapine, olanzapine, cyamémazine, lévomépromazine, etc.
- ▶ certains antidépresseurs : tricycliques

🧑 syndrome parkinsonien (raideur musculaire)

- ▶ la plupart des antipsychotiques en fonction de la dose, sauf la clozapine, l'olanzapine et la quétiapine
- ▶ plus rarement, les antidépresseurs sérotoninergiques

🌀 vertiges, troubles de l'équilibre ou de la coordination motrice

- ▶ benzodiazépines et apparentés
- ▶ antidépresseurs
- ▶ lithium ou clozapine en cas de surdosage

💊 tous ces effets indésirables sont variables d'une personne à l'autre, par ex. certaines personnes peuvent avoir des effets sédatifs importants avec des antidépresseurs réputés non sédatifs comme la sertraline, et vice-versa.

📅 le début du traitement est la période la plus à risque, mais le risque persiste quelle que soit la durée pour des médicaments comme les benzodiazépines par ex.

! Le risque de chute augmente avec :

- ▶ l'âge
- ▶ le nombre de médicaments psychotropes
- ▶ la consommation d'alcool
- ▶ l'association avec d'autres médicaments à risque (antihypertenseurs, opiacés par ex.)
- ▶ la présence de pathologies à risque (maladie de Parkinson ou démence par ex.)

🏠 Du fait des chutes, les usagers de psychotropes ont un risque augmenté de fractures, qui se cumule avec d'autres facteurs de risque également plus fréquents chez ces personnes :

- ▶ ostéoporose compliquant l'hyperprolactinémie induite par les antipsychotiques
- ▶ sédentarité
- ▶ faible exposition au soleil, etc.

🧠 La prévention des chutes et des fractures nécessite

- ▶ d'informer les usagers de ce risque
- ▶ d'éviter si possible les associations médicamenteuses à risque
- ▶ d'identifier rapidement la survenue d'effets indésirables à risque (syndrome extrapyramidal, hypotension orthostatique, troubles de l'équilibre, hyperprolactinémie, carence en vitamine D, etc.)
- ▶ une prise en charge pluriprofessionnelle avec des psychomotriciens et kinésithérapeutes

Références ↓

<https://doi.org/10.1016/j.jamda.2017.12.098>

<https://doi.org/10.1002/gps.4974>

<https://doi.org/10.1097/YIC.0000000000000221>

